

Risikofaktoren für Harn-/ Stuhlinkontinenz für alle Geschlechter (n. d. ES Kontinenzförderung 2024)	Harn-inkontinenz	Stuhl-Inkontinenz	Begründung/Erläuterung
Lebensalter	X	X	
Pflegebedürftigkeit	X	X	
Kognitive Beeinträchtigungen z. B. bei postoperativen bzw. posttraumatischen Delir, Demenz	X	X	
Körperliche Beeinträchtigungen in Bezug auf die Mobilität, die Fingerfertigkeit oder Störungen der Sinneswahrnehmung	X	X	
Neurogene Erkrankungen/Veränderungen z. B. bei Apoplex, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Rückenmarksverletzungen/ -läsionen, Tumore	X	X	

Risikofaktoren für Harn-/ Stuhlinkontinenz für alle Geschlechter (n. d. ES Kontinenzförderung 2024)	Harn-inkontinenz	Stuhl-Inkontinenz	Begründung/Erläuterung
Veränderungen/Operation der Prostata	X*		
Erkrankungen/Veränderungen des Darms z. B. bei Tumorerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Rektum-/Analprolaps, Rektozele		X	
Erkrankungen/Veränderungen der Blase z. B. bei Tumorerkrankungen, Cystocele	X		
Anomalien/Traumata/Operationen im Urogenitaltrakt z. B. bei orthotope Neoblase, Geschlechtsangleichung, Genitalverstümmelung, Genitalbeschneidung	X	X	

Risikofaktoren für Harn-/ Stuhlinkontinenz für alle Geschlechter (n. d. ES Kontinenzförderung 2024)	Harn-inkontinenz	Stuhl-Inkontinenz	Begründung/Erläuterung
Anomalien/Traumata/Operationen im Bereich Rektum, Anus und Dammbereich z. B. Hämorrhoiden, Fisteln, Analwarzen, höhergradige Geburtsverletzungen	X	X	
Enterostomarückverlegung		X	
Nebenwirkungen/Beeinflussung der Organfunktion durch Medikamente Möglicher Einfluss auf die <u>Harnkontinenz</u> : z. B. Anticholinergika, Diuretika, Opioide bzw. auf die <u>Stuhlinkontinenz</u> z. B. Opioide, Psychopharmaka	X	X	
Obstipation, chronische Diarrhoen z. B. durch bestimmte Medikamente, wie Chemotherapeutika, Antibiotika, Opioide	X	X	

Risikofaktoren für Harn-/ Stuhlinkontinenz für alle Geschlechter (n. d. ES Kontinenzförderung 2024)	Harn-inkontinenz	Stuhl-Inkontinenz	Begründung/Erläuterung
Harnwegsinfektionen	X		
Bestrahlungen im Beckenbereich	X	X	
Belastung des Beckenbodens z. B. in Folge von Schwangerschaft/Entbindung, Lageveränderung/ Vergrößerung des Uterus, Hysterektomie, Uterusprolaps oder chronischer Belastungen, Adipositas, schweres körperliches Arbeiten, chronischer Husten	X**	X	
Folgen sexualisierter Gewalt z. B. in Folge von Verletzungen im Beckenboden-/ Vaginalbereich, der Harnröhre, im Damm-/Analsbereich	X	X	

Risikofaktoren für Harn-/ Stuhlinkontinenz für alle Geschlechter (n. d. ES Kontinenzförderung 2024)	Harn-inkon-tinenz	Stuhl-Inkon-tinenz	Begründung/Erläuterung
Folge von Sexualpraktiken	X	X	
Pathologische Verhaltensweisen z. B. langes Einhalten, häufige vorsorgende Toilettengänge	X	X	
Umgebungsfaktoren z. B. schlechte räumliche Bedingungen, erschwerte Zugänglichkeit einer Toilette, fehlende Hilfsmittel	X	X	

* nur bei Männern / ** insbesondere bei Frauen